

# ממשק עבודה אא"ג ומלר"ד הדסה עין כרם

נובמבר 2025



# ממשק עבודה אא"ג ומלר"ד הדסה עין כרם

## מטרת המסמך

לבסס את שיתוף הפעולה בין אא"ג לרפואה דחופה לצורך זיהוי מוקדם של מצבים מסכני חיים ולמניעת סיבוכים כמו גם לדייק את הטריאז'. המסמך נועד לסייע בהחלטה מתי לפנות, באיזה אופן, וכיצד לשפר את איכות הטיפול המשותף.

ההנחיות הכתובות במסמך זה תקפות עד הוק וניתנות לשינוי בהתאם למורכבויות והשינויים שיעלו תוך כדי עבודה בהסכמת שתי המחלקות.

## מתי לערב רופא אא"ג?

מצבים הדורשים היועצות מיידית עם רופא אא"ג לפי רמת דחיפות. 

לפני קריאה לאא"ג. 

עקרונות לשיתוף פעולה תקין. 

סימני אזהרה שמחייבים אשפוז או השגחה. 

שיפורים מתמשכים. 

סוגיית פנייה בנושא סחרחורת. 



# ממשק עבודה אא"ג ומלר"ד הדסה

## מתי לערב רופא אא"ג?

### מצבים הדורשים היוועצות מיידית עם רופא אא"ג לפי רמת דחיפות

| מצב קליני                                                      | תיאור / דגשים                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קושי נשימתי על רקע עליון<br>צוות סיעודי/רפואי יוצר קשר עם תורן | אנגיואדמה, תגובה אלרגית קשה, חשד לאפיגלוטיטיס, סטרידור, יש<br>לשאוף לבדוק את המטופל בחדר הלם/בחדר קשם<br>מורסה פריטונסילרית חמורה, גוף זר - בחדר טיפולים במחלקת אאג |
| דימום אפי עקשני (Epistaxis)                                    | שאינו מגיב ללחיצה / צריבה / טמפונים בסיסיים, או חשד לדימום<br>אחורי.                                                                                                |
| פציעות ראש/צוואר                                               | כשיש מעורבות של איברים אנטומיים בתחום אא"ג.                                                                                                                         |
| גוף זר באוזן / אף / גרון                                       |                                                                                                                                                                     |
| ירידה פתאומית בשמיעה                                           | נדרשת הערכה מהירה - זמן = שמיעה.                                                                                                                                    |
| שיתוק עצב הפנים (Bell's palsy)                                 | רק במידה ויש חום, כאב אוזן, דלקת נלווית או כל הסתמנות שאינה<br>אופיינית                                                                                             |
| דלקת אוזניים עם סיבוכים או קושי בהערכה                         | צרומן חוסם, הפרשה<br>שיתוק עצב פנים, חשד לסיבוך אינטרקרניאלי                                                                                                        |
| פצעים / דלקות בצוואר                                           | חשד למורסה צווארית עמוקה, קושי בבליעה או טריזמוס. ארוע חוזר<br>תוך פחות מחודש ימים                                                                                  |
| פציעות טראומה                                                  | אא"ג אחראים על כל פציעות הצוואר אזור: 1,2,3.<br>אף- רק אם יש שבר, דימום בלתי נשלט או סחוס חשוף<br>אפרכסת- רק אם יש מעורבות של תעלת האוזן                            |
| חשד לסיבוכים של סינוסיטיס                                      | דלקת בסינוסים עם מעורבות עיניים, מעורבות אינטרקרניאלית                                                                                                              |

# ממשק עבודה אא"ג ומלר"ד הדסה עין כרם

## מתי לערב רופא אא"ג?

### לפני קריאה לאא"ג

(במידה ולא מדובר ברמת דחיפות 1 אדומה) - נא לוודא:

תיעוד מלא בתיק (סימפטומים, ממצאים, טיפול ראשוני)   
במידה ויש חשד לתגובה אלרגית יש לפעול על פי הסכמה הבאה: 

### תגובה אלרגית/אנפילקסיס



**במידה ויש אי וודאות לגבי מעורבות דרכי אוויר יש לבקש הערכה של רופא בכיר על מעורבות של דרכי אוויר.**

בדיקה בסיסית תקינה (למשל: אוטוסקופיה, הסתכלות בגרון, מצב נשימתי).   
ניסיון ראשוני בטיפול (פדים עם הקסאקפרון, משככי כאבים, שאיבה עדינה).   
תיאום תעדוף מול אא"ג במקרה של עומס - שיחה טלפונית ברורה! (טלפון לתורן אא"ג- לפי רשימת תורנים). 

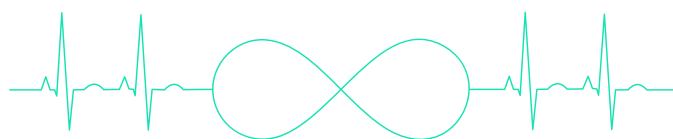
# ממשק עבודה אא"ג ומלר"ד הדסה עין כרם

## מתי לערב רופא אא"ג?

### עקרונות לשיתוף פעולה תקין

- פנייה ממוקדת ומנומקת - מונעת עיכובים מיותרים.
- התייעצות רפואית ≠ הפניה גורפת - לא כל תלונה באוזן/אף/גרון מחייבת מעורבות אא"ג.
- לרוב תלונה על כאבי ראש אינה זקוקה להערכה של אא"ג (למעט מקרים שיש חשד לסיבוכים של מחלה קיימת כגון חשד לסיבוכ של סינוסיטיס, חשד לבעיה עם שתלים קוכלאריים.. אחר).
- שיתוף בקבלת החלטות על שחרור/השגחה - במיוחד במקרים גבוליים.
- שמירה על תקשורת פתוחה - הדדיות, כבוד מקצועי וזיהוי מגבלות הזמן.

**על סמך עקרונות אלו ואישורם ע"י הצוותים הרפואיים בין שתי המחלקות בשעה שאחות קוראת לאא"ג או מפנה מטופל לניהול אא"ג, במצבו בו לרופא יש השגות על טריאז' זה עליו לבדוק את המטופל לכתוב דעתו ולהעביר את המטופל הלאה להמשך בירור הרלבנטי לפי הערכתו.**



# ממשק עבודה אא"ג ומלר"ד הדסה עין כרם

## מתי לערב רופא אא"ג?

### סימני אזהרה שמחייבים אשפוז או השגחה

- אנגיואדמה.
- תגובה אלרגית משמעותית עם חשד לפגיעה בדרכי נשימה עליונות.
- קוצר נשימה עם סטרידור.
- חום גבוה עם נפיחות צווארית.
- כאב גרון עם סטיית ענבל או טריזמוס.
- ירידת שמיעה פתאומית.
- אפיסטקסיס חוזר למרות טיפול.
- סיבוכים של דלקת אוזניים.

### שיפורים מתמשכים

- הצפת מקרים חריגים/מורכבים.
- עדכון נהלים בהתאם לצרכים קליניים.
- הטמעת בדיקת אא"ג (כולל תירגולים על בדיקת סיב) בקרב הצוות הרפואי והסיעודי.

### סוגיית פנייה בנושא סחרחורת

סחרחורת הינה מהפניות הנפוצות במלר"ד. המורכבות באבחנה בין סחרחורת פריפרית למרכזית מהווה אתגר גדול בבירור החולים במלר"ד ולעיתים יוצרת עומס על צוות אא"ג שלא לצורך.

לרוב אם יש רושם שישנה סחרחורת ממקור פריפרי אין דחיפות בבדיקת רופא אא"ג למעט תסמינים המתווספים לסחרחורת כגון, ירידה פתאומית בשמיעה, ירידה בתחושת הפנים.



המרכז הרפואי  
האוניברסיטאי  
**הדסה**

מיסודו של ארגון נשות הדסה



**HADASSAH  
CARE-EM**  
**Excellence**  
in Emergency Medicine